

Le principe du traitement et du suivi des maladies systémiques

I. Introduction :

- Les maladies systémiques sont liées à :
 - Une inflammation excessive
 - Une réaction auto-immune
 Sur un terrain génétiquement prédisposé, avec souvent la présence de facteurs environnementaux
- Elles évoluent par poussées / rémissions
- Le traitement repose sur : les anti-inflammatoires, les immunosuppresseurs et immunomodulateurs, ainsi que sur l'éviction des facteurs déclenchant les poussées
- On distingue :
 - Les mesures qui visent à éliminer les facteurs pouvant favoriser la survenue d'une poussée
 - Les traitements symptomatiques qui visent à atténuer les symptômes
 - Les traitements de fond qui ont pour but de limiter les récurrences et de prévenir les poussées
 - Il n'y a pas de traitement éradicateur
 - Le traitement d'attaque a pour but d'obtenir une rémission
 - Le traitement d'entretien a pour but de maintenir la rémission
 - Le suivi repose sur la recherche d'effets secondaires et permet de s'assurer de l'efficacité du traitement

II. Principaux traitements :

1. Hydroxychloroquine (Plaquenil*) :

- Anti-malarique de synthèse qui a des propriétés anti-inflammatoires et immunomodulatrices
 - Posologie : 400mg/j
 - Indications : traitement de fond dans le lupus érythémateux systémique, traitement des manifestations rhumatismales des maladies systémiques.
 - Effet secondaire principal : toxicité rétinienne qui imposera l'arrêt du traitement
 - Surveillance : examen ophtalmologique, fond d'œil, champs visuels et électrorétinogramme

2. Anti-inflammatoires non stéroïdiens :

- Utilisés en cas de manifestations articulaires isolées
- Effets secondaires : toxicité digestive, toxicité rénale

3. Corticothérapie générale : Anti-inflammatoire puissant et immunosuppresseur à forte dose

- Prednisone : Cortancyl*, Precortyl* cp 5mg
- Méthylprednisolone : Solumedrol* ampoules injectables (40mg, 500mg, 1000mg)
- **Posologie et indications variables** : 0,5mg/kg/j à 1mg/kg/j (prednisone) (si atteintes viscérales) pendant la phase d'attaque (4 à 6 semaines), puis diminution progressive de la posologie durant la phase d'entretien
 Bolus de 500mg à 1g/j (solumedrol) pendant 3 à 5 jours si poussées graves (à diluer et à faire passer en perfusion 30mn à 3heures)
- **Effets indésirables** :
 - Acné, hirsutisme, retard à la cicatrisation, fragilité capillaire érythrose, vergetures
 - Syndrome cushingoïde avec redistribution fascio-tronculaire des graisses
 - Lipolyse avec hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie
 - Hyperglycémie par augmentation de la néoglucogénèse et de la glycogénolyse. Diminution de l'utilisation périphérique du glucose
 - Balance azotée négative : catabolisme protéidique augmenté, synthèse hépatique diminuée, atrophie et faiblesse musculaire entraînant une myopathie cortisonique
 - Hypokaliémie
 - Rétention hydrosodée : œdèmes, HTA, décompensation d'une insuffisance cardiaque préexistante
 - Glaucome, cataracte
 - Insomnie, euphorie, dépression ou aggravation d'une psychose
 - Ostéonécrose aseptique : tête fémorale ou autres, ostéoporose
 - Épigastralgies, nausées et vomissements
 - Freination de l'axe corticotrope
 - Troubles du rythme et arrêt cardiaque (bolus administré en moins de 30mn)

- **Modalités de prescription, précautions d'emploi et surveillance :**

- Utiliser la dose minimale efficace et sur une durée la plus courte possible
- Associer : un régime hyposodé, pauvre en sucres, riche en protides.
- Traitements adjuvants : supplémenter en potassium, en vitamine D et en calcium, inhibiteur de la pompe à protons si antécédents d'ulcère digestif
- Activité physique régulière
- Dépistage et traitement d'une éventuelle ostéoporose, d'un diabète, d'une HTA
- Surveillance et correction d'une hypokaliémie
- Arrêt progressif de la corticothérapie : permet d'éviter une insuffisance surrénalienne, et de prévenir un effet rebond de la maladie
- Prise le matin

4. Immunosuppresseurs : Bloquent une ou plusieurs étapes de la réponse immunitaire

- **Indications :**

- Poussée grave avec un pronostic vital ou un pronostic fonctionnel d'un organe mis en jeu
- Corticodépendance / corticorésistance

- **Les molécules les plus utilisées en médecine interne :**

- ✓ Cyclophosphamide (endoxan*) : action sur l'immunité cellulaire et l'immunité humorale

- **Posologie et mode d'administration :** 0,5 à 0,8g/m²/mois en perfusion pendant 6 mois puis 1 cure/3mois, sans dépasser 12 cures

- **Effets indésirables :**

- Nausées, vomissements
- Alopécie
- Toxicité médullaire (lymphopénie, neutropénie)
- Insuffisance ovarienne, aménorrhée
- Azoospermie
- Toxicité vésicale : cystite hémorragique avec risque de cancer
- Infections
- Effet tératogène

- **Surveillance et précautions d'emploi :**

- Hydratation ++++
- Adjunction d'un protecteur de vessie
- Conservation des ovocytes / du sperme
- Contraception
- Surveillance : FNS, fonction rénale, syndrome infectieux

- ✓ Méthotrexate (MTX) : cp à 2,5 mg : antagoniste de l'acide folique

- **Posologie :** débuter par 7,5 mg/semaine et selon la réponse jusqu'à 0,3mg/kg/semaine

- **Effets indésirables et surveillance :**

- Digestifs : mucite prévenue par l'association avec l'acide folique 24 à 48h après la prise du MTX, nausées, vomissements
- Alopécie
- Cytopénies (surveillance de la FNS), infections
- Cytolyse hépatique et/ou cholestase (surveillance de la fonction hépatique)
- Pneumopathie interstitielle (surveillance clinique, Rx, EFR)

- ✓ Azathioprine (Imurel*) : cp à 50mg : action sur les lymphocytes T

- **Posologie :** 2 à 3mg/kg/j

- **Effets indésirables :** c'est l'immunosuppresseur le mieux toléré.

Nausées, vomissements, cytopénie, hépatite, pancréatite.

- **Surveillance :** FNS et fonction hépatique

- ✓ Mycophénolate mofetil (Cellcept*) : cp à 500mg : inhibe la prolifération des lymphocytes T et B

- **Posologie :** 2 à 3g/j

- **Effets indésirables :** digestifs, hépatiques, hématologiques, infections

5. Biothérapies : Utilisées en seconde ligne en cas d'échec aux immunosuppresseurs classiques

- **Effets secondaires :** infections opportunistes, nausées, diarrhée, cytopénies, hépatite, troubles neurologiques

- ✓ Anti TNF α : infliximab / adalimumab

- ✓ Anti CD20 : Rituximab